

A CORRELAÇÃO ENTRE A PSICOLOGIA E A ESPIRITUALIDADE NA FORMAÇÃO DA PERSONALIDADE

UNIDADE IV A ESPIRITUALIDADE NA CLÍNICA

Unyleya
EDUCACIONAL



Elaboração

Arquiléia Itair Peixoto Gonçalves

Produção

Equipe Técnica de Avaliação, Revisão Linguística e Editoração

SUMÁRIO

UNIDADE IV

A ESPIRITUALIDADE NA CLÍNICA	5
------------------------------------	---

CAPÍTULO 1

O TERAPEUTA COMO UM FACILITADOR	6
---------------------------------------	---

CAPÍTULO 2

O PROFISSIONAL E O RECONHECIMENTO DA IMPORTÂNCIA DA ESPIRITUALIDADE NA CLÍNICA	10
---	----

CAPÍTULO 3

A ESPIRITUALIDADE COMO FACILITADORA DO PROCESSO SAÚDE/DOENÇA	16
--	----

PARA (NÃO) FINALIZAR.....	22
---------------------------	----

REFERÊNCIAS	23
-------------------	----

A ESPIRITUALIDADE NA CLÍNICA

UNIDADE IV



“O espiritual é um espaço dentro do corpo onde as coisas que não existem, existem.”

Prado (2015).

Sabe-se que a espiritualidade tem o poder de promover efeitos positivos ou negativos na saúde de um paciente. A relação de interdependência entre a religião e a medicina existe desde os tempos mais remotos. Segundo Lucchetti *et al.* (2010), os egípcios (2000-1800 a.C.) já exorcizavam espíritos usando o nome do Deus Hórus; os cientistas gregos (500-300 a.C.) já discutiam sobre a origem da alma; e, nos tempos medievais (1000-1200 d.C.), as autoridades religiosas eram as responsáveis pela concessão de licenças para a prática da medicina. São provas da existência da relação estreita entre a medicina e a religião. Tal relação foi mantida até o período da Renascença, quando houve uma ruptura que se manteve até o início do século XX.

Lucchetti *et al.* (2010) afirmam que a publicação do artigo *The faith that heals* (em português, “A fé que cura”), no *British Medical Journal*, escrito por Sir William Osler, professor de Medicina da Universidade Johns Hopkins (Osler, 1910), finalmente reaproximou as duas ciências – medicina e religião. Na década de 1960, começaram a ser publicados diversos estudos epidemiológicos que comprovavam a relação positiva entre espiritualidade e religiosidade na saúde dos pacientes.

Newberg e Lee (2005) destacam que, nas décadas seguintes, o conceito da chamada espiritualidade baseada em evidências cresceu. Isto é, o estudo dos mecanismos pelos quais a fé levaria a esses desfechos clínicos e a forma como os profissionais da medicina deveriam tratar esse assunto na prática clínica.

CAPÍTULO 1

O TERAPEUTA COMO UM FACILITADOR

O psicólogo clínico pode ser interpretado como um facilitador no processo terapêutico. Para Saldanha (1999), por isso, torna-se fundamental que ele possa reconhecer a dimensão espiritual do paciente como parte integrante da relação construída no processo de tratamento psicoterápico. Mesmo a psicologia assumindo a compreensão do indivíduo em sua esfera espiritual, não se admite, porém, a compreensão desse indivíduo a partir das suas manifestações no campo da espiritualidade na sua forma mística.

Compreender a vivência do místico apenas sob o olhar do registro psíquico é ignorar a profundidade do ser humano. Safrá (2007) afirma que o profissional que se propõe a sustentar o lugar da revelação da condição real humana do paciente fará com que esse paciente ganhe sua autonomia dando luz ao saber que nele emerge.

Tratamentos psiquiátricos e psicoterapêuticos com abordagens espirituais estão num estágio inicial. Não existe consenso sobre uma linha de estudo que integre a espiritualidade na terapia dos pacientes que sofrem de transtorno e doenças psiquiátricas. A falta de consenso ocorre principalmente por conta das preocupações sobre a possibilidade de os efeitos colaterais encorajarem e darem suporte ao envolvimento religioso, sem controle. Porém, por outro lado, são crescentes as evidências de resultados positivos nos tratamentos a partir das abordagens religiosas e espirituais nos transtornos psiquiátricos.

Frankl (1994) compreende espiritualidade como sendo uma dimensão humana única. Blanch (2007) considera que a espiritualidade torna a vida sagrada e com sentido. Ainda sobre espiritualidade, Matthiews (1998) afirma ser uma parte essencial da relação médico-paciente e do processo de recuperação do paciente.

A psicologia tem concentrado esforços no sentido de estudar a espiritualidade/religiosidade e sua relação com a saúde mental, com o bem-estar psicológico e com a integração bio-psico-socio-espiritual dos indivíduos. Para Lancetti e Amarante (2006), saúde mental pode ser descrita como uma mente saudável. Segundo os autores, essa mente saudável seria o resultado de um movimento contínuo do indivíduo em busca do seu bem-estar, de modos de vida que o sustentem diante das adversidades do cotidiano e que o ajudem num processo de mudança e produção da subjetividade e não apenas a ausência de doenças.

Nos *gaps* existentes nas tentativas de desvendar o funcionamento psicológico do ser humano, a espiritualidade na clínica se torna importante quando diagnósticos errados começam a chegar aos consultórios. Com essa perspectiva, a psicologia pode oferecer melhores recursos para a espiritualidade no estudo do homem como criatura com grandes possibilidades de ajustamentos. Segundo Allport (1966), esse mesmo homem



que se organiza socialmente de forma religiosa e oportunística é resultado de uma condição tribal. O autor acrescenta que esse homem pode ser compreendido também como sendo um indivíduo autocrítico, autoafirmativo, que busca sua integridade e uma inter-relação com um Ser maior, como característica principal da sua espiritualidade. “A psicologia que impede a compreensão das potencialidades religiosas do homem, dificilmente poderá ser denominada um ‘logos’ da psique humana” (ALLPORT, 1966).

A visão de saúde mental descrita por Lancetti e Amarante abre espaço para se pensar também o papel da espiritualidade na saúde mental.

Para melhor compreensão do tema, faz-se necessário definir os conceitos básicos de religião, religiosidade e espiritualidade. Para tanto, serão utilizadas as definições de Koenig, McCullough e Larson (2001):

- » **Religião** – refere-se ao sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos designados para facilitar o acesso ao sagrado, ao transcendente – Deus, a força maior, a verdade suprema.
- » **Religiosidade** – refere-se à crença do indivíduo, o quanto ele segue e pratica uma religião. A religiosidade pode ser organizacional – participação do indivíduo na igreja ou templo religioso – ou não organizacional – rezas, leitura de livros santos/religiosos, interesse por programas religiosos na televisão.
- » **Espiritualidade** – refere-se à busca pessoal para compreensão das questões relacionadas à finitude, ao sentido da vida, às relações com o sagrado ou com o transcendente. A espiritualidade pode levar ou não o indivíduo a desenvolver e acompanhar práticas religiosas ou participar de comunidades religiosas.

A necessidade da medicina e dos seus profissionais aceitarem a espiritualidade do paciente como “remédio” para sua cura deve-se ao fato de que muitos são religiosos e, por isso, suas crenças os ajudam a lidar com diversos aspectos da vida e da finitude. Deve-se observar, também, que as crenças pessoais dos profissionais de saúde, segundo Curlin *et al.* (2007), exercem influência nas suas decisões, tanto por parte do paciente quanto dos próprios médicos. Os autores citam como exemplo o paciente Testemunha de Jeová, que não aceita o uso de hemoderivados, e os médicos que se recusam a prescrever anticoncepcionais devido aos seus princípios religiosos. Koenig (2001) afirma que as atividades e crenças religiosas estão relacionadas à melhora da saúde e da qualidade de vida.

Não se pode dividir o paciente em várias dimensões, como social, biológica, psíquica e espiritual. Essas dimensões são interligadas, e a sua relação pode ser responsável tanto pelas doenças quanto pela aderência aos medicamentos, resultando no sucesso ou no fracasso no tratamento.

Mais especificamente, com relação à saúde mental, as pesquisas têm apresentado maior relação entre espiritualidade e religiosidade, incluindo menor prevalência de depressão (SMITH; MCCULLOUGH; POLL, 2003), tempo menor de remissão da depressão após o tratamento (KOENIG; GEORGE; PETERSON, 1998), menor prevalência de ansiedade (BOSCAGLIA *et al.*, 2005) e menor taxa de suicídio (RASIC *et al.*, 2009). Em relação à melhor qualidade de vida, igualmente, os estudos demonstram uma relação positiva com espiritualidade e maior bem-estar geral (LEVIN; MARKIDES; RAY, 1996).

A forma e o momento da abordagem da espiritualidade com o paciente poupam a possibilidade de algum mal-entendido, segundo Koenig (2005). Para o autor, o bom senso deve prevalecer. Uma abordagem direta, em situações extremas, como acidentes e eventos isquêmicos coronarianos, pode levar ao sentimento de medo/pavor no indivíduo. Porém, em um exemplo de caso de avaliação ambulatorial de um novo paciente, que será acompanhado pelo mesmo médico, pode ser o melhor momento para a obtenção da história espiritual. Na anamnese do paciente, além da inclusão da história social, das perguntas sobre as atividades físicas, dos hábitos e dos vícios, pode incluir, também, a abordagem da espiritualidade.

Existem várias formas para abordar a espiritualidade, porém não existe uma forma correta. A abordagem pode ser feita de forma natural, a depender das próprias convicções e da herança cultural do profissional de saúde. Os pesquisadores têm, entretanto, criado mecanismos com o propósito de facilitar a abordagem da espiritualidade com os pacientes. Os instrumentos servem como modelo para a obtenção da história espiritual, conforme descritos nos quadros a seguir.

Quadro 3. Questionário FICA.

F – Fé / crença Você se considera religioso ou espiritualizado? Você tem crenças espirituais ou religiosas que te ajudam a lidar com problemas? Se não: o que te dá significado na vida? I – Importância ou influência Que importância você dá para a fé ou crenças religiosas em sua vida? A fé ou crenças já influenciaram você a lidar com estresse ou problemas de saúde? Você tem alguma crença específica que pode afetar decisões médicas ou o seu tratamento? C – Comunidade Você faz parte de alguma comunidade religiosa ou espiritual? Ela te dá suporte? Como? Existe algum grupo de pessoas que você “realmente” ama ou que seja importante para você? Comunidades, como igrejas, templos, centros, grupos de apoio, são fontes de suporte importante? A – Ação no tratamento Como você gostaria que o seu médico ou profissional da área da saúde considerasse a questão religiosidade / espiritualidade no seu tratamento? Indique, remeta a algum líder espiritual / religioso.

Fonte: Puchalski; Romer, 2000.



Quadro 4. Questionário HOPE.

H - Fontes de Esperança (Hope), significância, conforto, força, paz, amor e relacionamento social.

Quais são as suas fontes de esperança, força, conforto e paz?

Ao que você se apegua em tempos difíceis?

O que o sustenta e o faz seguir adiante?

O – Religião organizada

Você faz parte de uma comunidade religiosa ou espiritual? Ela o ajuda? Como?

Em que aspectos a religião o ajuda e em quais não o ajuda muito?

P – Espiritualidade pessoal e prática

Você tem alguma crença espiritual que é independente da sua religião organizada?

Quais aspectos de sua espiritualidade ou prática espiritual você acha que são mais úteis à sua personalidade?

E – Efeitos no tratamento médico e assuntos terminais

Ficar doente afetou sua habilidade de fazer coisas que o ajudam espiritualmente?

Como médico, há algo que eu possa fazer para ajudar você a acessar os recursos que geralmente o apoiam?

Há alguma prática ou restrição que eu deveria saber sobre seu tratamento médico?

Fonte: Anandarajah; Hight, 2001.

Para atendimento de pacientes sem histórico religioso, em vez de focar na espiritualidade, o médico pode questionar como ele convive com a doença, o que promove o significado e sentido à sua vida ou, ainda, qual crença cultural pode ter impacto positivo no seu tratamento.

Koenig (2005) destaca que nem sempre os efeitos da religião são positivos. Por isso, segundo o autor, é importante que os profissionais da área da saúde estejam atentos para a possibilidade de a religião desencadear problemas – casos, por exemplo, em que há uma sensação de que Deus está punindo ou abandonando o paciente – e provocar conflitos quanto ao tratamento.

O profissional da área médica deve saber o melhor momento e a forma correta de abordar a dimensão espiritual do paciente, evitando julgar suas preferências religiosas.



Leia o artigo “Integrando religião e espiritualidade no cuidado em saúde mental, na psiquiatria e na psicoterapia”, de René Hefti, disponível em: <https://revistas.ufpr.br/psicologia/article/view/68486>.

CAPÍTULO 2

O PROFISSIONAL E O RECONHECIMENTO DA IMPORTÂNCIA DA ESPIRITUALIDADE NA CLÍNICA

Como descrito no capítulo anterior, existe um número grande de estudos e pesquisas acerca da temática espiritualidade/religiosidade e sua relação com a saúde e, mais especificamente, com a saúde mental. Segundo Guimarães e Avezum (2007), as evidências da maioria dos estudos apontam que a espiritualidade exerce forte influência na prevenção da saúde. Outros estudos comprovam que as práticas espirituais e religiosas têm sido relacionadas a taxas menores de depressão e de estresse e maiores de qualidade de vida.

Considerando a perspectiva de que a doença mental, diferentemente dos outros tipos de doenças, é para o portador mais do que uma enfermidade, é um sofrimento, pode-se inferir que a subjetividade faz parte desse ser humano. E é nesse contexto que surge a reflexão acerca da relação entre espiritualidade e o tratamento do doente mental, uma vez que é uma dimensão importante na subjetividade do indivíduo.

Embora os dois constructos – religiosidade e espiritualidade – admitam sobreposição nas suas definições, a diferença principal é que a primeira oferece clara sugestão de um sistema de adoração e doutrina específica que é partilhada com um grupo. Para Fleck *et al.* (2003), religiosidade é a extensão na qual um indivíduo acredita, segue e pratica uma religião. Diferentemente, espiritualidade não está necessariamente ligada a uma crença em um ser superior ou a princípios religiosos.

Historicamente, as políticas de saúde mental sofreram modificações, assim como a sua relação com a espiritualidade/religiosidade. Koenig (2005) afirma que até o século XX a religião era vista como possível causadora de neuroses. O autor informa que esse pensamento começou a mudar a partir do século XXI, quando a relação com a religião passa a ser considerada como um fator positivo para a saúde, principalmente para a saúde mental.

Num cenário em que religiosidade e espiritualidade eram tidas como influência negativa sobre a saúde, principalmente a saúde mental, as práticas espíritas e mediúnicas emergiam. Entre o século XIX e a primeira metade do século XX, segundo Almeida, Oda e Dalgalarondo (2007), a postura predominante entre os psiquiatras no Brasil, principalmente no do eixo Rio de Janeiro x São Paulo, foi combativa em relação a estas práticas. Havia, também, uma grande disputa entre as verdades da religião e da ciência para explicação dos fenômenos mediúnicos, da mente e das doenças mentais.

Segundo Almeida, Oda e Dalgalarondo (2007), a partir da década de 1950, quando os fenômenos mediúnicos começaram a integrar o universo cultural da sociedade pelos



discursos psiquiátricos, a religião passou, gradativamente, a ser vista como uma possível colaboradora no processo de tratamento dos pacientes doentes mentais.

A partir desse movimento de aceitação da religião no processo de cura dos pacientes, surge o fator espiritualidade – condição humana de busca pelo sentido da vida. A espiritualidade, assim, passa ser vista como forma de contribuição para o bem-estar físico e mental, que age como fator de proteção e contra o desenvolvimento de doenças físicas e psíquicas.

O mistério da existência humana é um elemento presente na experiência religiosa, que é mais explicitado quando se considera a dimensão espiritual do indivíduo. A existência humana é reconhecida, porém vivida com surpresa e admiração. O mistério da existência humana provoca interrogações, pois as pessoas buscam compreender a si mesmas e ao mundo.

Na abordagem clínica da psicologia, a dimensão do mistério da existência humana se mantém presente, mesmo quando se busca compreender os efeitos do encontro humano, ou que haja condições que facilitem esse entendimento. Ou seja, por mais que se recorra a teorias, métodos ou técnicas, nenhuma explicação da transformação vivenciada na relação é suficientemente segura. Luczinski (2005) questiona:

- » O que de fato muda?
- » O que produz a mudança?

Segundo a autora, cada abordagem oferece uma ou mais respostas. Porém, cada resposta aponta apenas um aspecto parcial da realidade. Ela explica que, ao reconhecer o ser humano como múltiplo, singular e dotado de uma ontologia específica, na atuação clínica sempre haverá algo que escapa do controle na relação interpessoal.

Na relação existente entre o psicoterapeuta e o paciente, considerar a existência de algo que os ultrapassa poderá produzir uma abertura frente ao fenômeno do mistério da existência humana. Esse fenômeno, que pode ser perceptível na relação psicoterápica, está presente no cotidiano. A partir de situações, gestos, sensações que rompem o habitual ou acontecimentos que colocam o indivíduo diante do imprevisível.

Prado (1999) afirma que, entre as diversas vivências humanas, duas se destacam por colocarem a pessoa diante do mistério: as experiências estética e religiosa. Tanto a arte quanto o misticismo se propõem desvendar algo que se vive intensamente. Revelam-se por meio de formas de expressão. Os universos artísticos e místicos dão vazão aquilo que é inominável, pois não têm palavras que dão conta das experiências vividas. Assim, apenas a linguagem e o universo fluido artístico ou o religioso conseguem expressar esse tipo de vivência, que tem um caráter totalmente singular.

Para Prado (1999), tanto a fé quanto a arte oferece possibilidades humanas da mais absoluta originalidade, nas quais o indivíduo é único e singular. Nas duas situações, o autor afirma que a pessoa é instigada a se desdobrar, se transcender e buscar uma forma de dar voz ao que experimenta. É quando o indivíduo deixar de se tocar pelo caráter misterioso dessas experiências, que ele cria diferentes ferramentas, produzindo um saber sobre si mesmo e sobre o mundo. Essa possibilidade descrita pelo autor é encontrada, também, na psicoterapia enquanto encontro humano.

Safra (1998) descreve a vivência do sagrado como um caminho para a singularidade. O sagrado, para o autor, pode estar relacionado à arte ou a outros universos, não estando necessariamente ligado a crenças em um Outro Absoluto. Na mesma linha, Ales Bello (2004) considera que a busca de potência no ser humano é algo marcante e se manifesta mais claramente por meio da religião. O autor afirma que o ser humano percebe sua finitude e seus limites, mas, mesmo assim, alimenta o desejo de superá-los, de ir além. Ele deseja a potência, tanto na sua vida quanto no sentido da existência. A experiência do sagrado se dá quando a potência é identificada mediante uma realidade material, dando algum sentido à sua busca perene. No contato com o mistério, a pessoa pode, então, encontrar potenciais objetos de suas buscas.

Safra (1998) defende que o sentimento religioso pode ser compreendido como “uma tentativa de busca do sagrado, entendido como o anseio da potência de ser” (p.175).

Nesse ponto, para o autor, crescimento pessoal, tanto do ponto de vista psicológico quanto religioso, encontra-se, sendo possibilidades e caminhos diferentes na busca pela potência de ser. Contudo, o autor destaca que a dimensão psicológica jamais esgota ou substitui essa busca de potência no seu sentido pleno e mais amplo. Por sua vez, na dimensão religiosa, o indivíduo busca por uma potência pertencente ao âmbito do divino, transcende à realidade e à condição humanas.

Otto (1985) considera importante e fundamental a força do sagrado e dos aspectos vivenciais da experiência religiosa. Assim como Ales Bello (2004), esse autor enfatiza as sensações trazidas pela forma física e concreta de certas coisas que levam a uma abertura ao transcendente. Otto constata que elementos de diversas culturas (paisagens exuberantes e construções imponentes) despertam nos indivíduos sentimentos de maravilhamento que apontam para a existência de algo maior. O autor denomina esse sentimento de numinoso. O numinoso, na perspectiva de Otto, surge da necessidade humana de conhecer e é solicitado a partir das impressões sensíveis. É por meio da descrição fenomenológica de lugares e construções humanas que o autor descreve a dimensão do mistério presente no mundo. O momento de compreensão e denominação do que se vive é, para Ales Bello (2004), noético, ou seja, o aspecto racional é utilizado para conferir significados.



Assim, a partir dessas considerações, pode-se aceitar a expressão senso religioso como mais adequada do que sentimento religioso. A apreensão e a vivência religiosas coordenam um conjunto de eventos subjetivos e objetivos acontecendo simultaneamente, que envolve a pessoa em todas as suas dimensões. Giussani (2000) afirma que senso religioso refere-se à exigência de significado da vida, expressando-se nas perguntas sobre o sentido de todas as coisas, diante do mistério da realidade humana. E essa concepção envolve um conceito de razão e de experiência específicos, que contemplam a totalidade e a complexidade do fenômeno religioso.

A dimensão religiosa tem, portanto, características muito específicas. Cada estudioso dessa área de conhecimento apresenta novos aspectos, demonstrando que essa dimensão é muito mais complexa.

Assim, o encontro da psicologia com a religião é necessário e urgente para que se busque uma forma de integração da teoria e da prática. Ancona-Lopez (2002) defende que esse diálogo deva explorar aproximações e distanciamentos, pois se trata de campos distintos e específicos. Para a autora, existe possibilidade da construção de pontes que facilitem o diálogo, por meio de um trabalho interdisciplinar, evitando reducionismos. Para Paiva (2002), os dois campos do saber buscam pelo sentido da vida e pela produção de conhecimento que objetivam a transformação pessoal. Já Ancona-Lopez (1999) afirma que o maior desafio desse diálogo é a manutenção do rigor exigido pela psicologia, enquanto ciência, mantendo, ao mesmo tempo, a dimensão de mistério requerida pelo campo religioso.

Ancona-Lopez (2002) destaca a grande dificuldade do psicólogo em articular a integração necessária às duas áreas do saber. Essa dificuldade ocorre, segundo a autora, pela falta, por parte dos psicólogos, de referências para lidar com a questão religiosa, resultado da falta de estudos, reflexões e interesse da psicologia pelo tema.

Wulff (1997) divide em quatro categorias de desenvolvimento da experiência religiosa, a partir das quais é possível avaliar diferentes situações ligadas à clínica psicológica:

- » **Negação literal** – nesta categoria, as pessoas negam por princípio as afirmações religiosas. Compreendem as afirmações religiosas nos seus aspectos formais e mais racionais. No caso dos psicólogos, tendem a desconsiderar a fé e as experiências trazidas pelos pacientes, ou seja, negam a transcendência. Tendem a não considerar as experiências de caráter simbólico e vivencial.
- » **Afirmação literal** – nesta categoria, predominam os fundamentalistas e os religiosos ortodoxos. Os psicólogos que adotam essa posição agem de acordo com suas crenças e os seus pressupostos religiosos. Apoiam-se nos seus pressupostos

religiosos muito mais do que nas teorias psicológicas para o desenvolvimento do seu trabalho. A partir das suas crenças religiosas, pretendem que seus pacientes vejam o mundo da mesma maneira, compartilhando sua fé.

- » **Interpretação redutiva** – nesta categoria, o psicólogo elimina a experiência transcendente e busca explicações psicológicas para o fenômeno religioso. O fenômeno religioso é reduzido à esfera psicológica. A psicanálise freudiana clássica é um exemplo clássico de interpretação redutiva, ou seja, essa abordagem psicoterápica reduz a experiência religiosa a questões psicopatológicas.
- » **Interpretação restauradora** – é a categoria que mais se aproxima de uma prática psicológica ética e coerente. Nessa perspectiva, a experiência religiosa é considerada como real e específica, mas há uma análise crítica das crenças e dos posicionamentos pessoais. O psicólogo está aberto para as vivências, os símbolos e as metáforas do paciente, buscando compreender e aproximar-se do fenômeno religioso. Essa forma de trabalho com o paciente implica humildade epistemológica e clareza quanto aos próprios pressupostos e adesões religiosas.

Ancona-Lopez (1999), ao considerar essa categorização proposta por Wulff (1997), destaca que isso não significa que o profissional se coloque de forma estática em uma delas. Pode, por exemplo, ser mais “redutivo” ou “restaurador” ou “negacionista” a depender da situação vivenciada. As respostas em face dos posicionamentos do tema religioso são oriundas da articulação de cada profissional que leva em conta sua dimensão pessoal, suas teorias e suas crenças. O que se deve levar em conta, para a autora, é a impossibilidade de separação entre as dimensões pessoal, cultural e profissional do psicólogo. A autora acrescenta que, no trabalho clínico, a relação entre a psicologia e a religião precisa ser incluída, sendo necessário explicitar as crenças religiosas daquele que se propõe a trabalhar com pessoas.

Bergin, Payne e Richards (1996) consideram importante a explicitação dos valores do Psicoterapeuta para o paciente, não somente os presentes na abordagem adotada, como também os religiosos que farão parte do tratamento. Essa atitude evita a formação de uma agenda oculta que somente o Psicoterapeuta conhece. Os autores afirmam que os valores do terapeuta, acabam por criar uma atmosfera para o tratamento que cria expectativas de como o paciente deve se comportar e no que ele que deve acreditar, por exemplo.

É igualmente importante o Psicólogo reconhecer os valores presentes nas diversas abordagens teóricas e como eles interferem na interação com a paciente. Não se pode esquecer que as abordagens teóricas não são verdades absolutas, apresentam falhas. Safra (2004) afirma que teoria e prática interagem permitindo



abertura para aprender com a experiência do paciente, permitindo ajustes na teoria e na prática a partir dessa interação.

Já Bergin, Payne e Richards (1996) alertam sobre a linha tênue que existe entre a exploração e crítica aos valores religiosos. Acrescentam que só um respeito profundo pelo paciente e seus valores pode promover uma mudança segura, preservando sua autonomia e seu processo. Os autores condenam o aconselhamento da desistência de algum fator da sua adesão religiosa, consideram essa prática uma invasão à integridade do paciente, isso inibe o processo terapêutico. Por outro lado, o contrário, ou seja, encorajamento de certas práticas religiosas, pode ter também o mesmo efeito invasivo da integridade do paciente.

O acolhimento de um paciente com forte experiência religiosa ou com questões relativas a esse tema exige um reposicionamento do psicólogo.



Leia o artigo "Espiritualidade e saúde – estudo caso-controle", de Maria Beatriz Andrade Marques Silva e colaboradores, disponível em: <http://periodicos.unincor.br/index.php/revistaunincor/article/view/3456>.

CAPÍTULO 3

A ESPIRITUALIDADE COMO FACILITADORA DO PROCESSO SAÚDE/DOENÇA

Na prática da psicoterapia clínica, é importante que o psicoterapeuta possa ajudar o paciente a utilizar todos os seus recursos. Em outras palavras, é positivamente terapêutico um trabalho que sustente a religiosidade e a espiritualidade emergente do paciente, independentemente dessa espiritualidade ser ateia ou crente. Ou seja, todo indivíduo possui um conhecimento inato, um saber que deseja pôr sentido e realização frente aos outros seres humanos. É um cuidado ético do psicoterapeuta com seu paciente, quando se leva em conta as dimensões da subjetividade humana. Não se trata, pois, de abordar questões de uma ou outra religião ou invadir o campo teológico místico do indivíduo, mas, sim, de exercer o cuidado integral com o ser humano.

Muito mais do que uma interpretação psicológica, são situações que demandam do psicólogo e dos outros profissionais de saúde uma postura ética filosófica que deverá contemplar a vida do paciente de forma abrangente e profunda. Deverá, também, ser dissociada das muitas nomeações intelectuais.

Saúde e doença, para Gioia-Martins e Rocha Junior (2001), são concepções que revelam uma carga histórica, cultural, política e ideológica. Por isso, a revisão dos valores culturais se revela como fonte transformadora do contexto e da organização sociais, surgindo, assim, a abordagem holística para estudo do homem. Nessa mesma linha, Teixeira (1996) opina que o nascimento do paradigma holístico ocorreu a partir da crise no campo da ciência, que admitia apenas objetividade e racionalidade como meios para conquista do conhecimento. A visão holística do ser humano fortalece o debate nas diversas ciências para novas construções e atitudes.

Diante dessa perspectiva de totalidade do ser humano, outras dimensões se somaram às biológicas e sociais. Por isso, Rocha e Monteiro (2017) afirmam que a flexibilidade paradigmática traduz a transformação que o conceito biopsicossocial está passando. Isto é, de forma lenta, o conceito vem se transformando em biopsicossocial espiritual.

São cinco as dimensões que envolvem o conceito biopsicossocial espiritual do homem – biológica, psicológica, social, espiritual e ambiental.

Biológica – este contexto foi descrito por Straub (2005) como sendo a composição genética, os sistemas nervoso, imunológico e endócrino. Para a psicologia da saúde, esses fatores físicos do organismo humano sofrem influências na saúde e na doença e ocorrem de maneira sistêmica, na interação da dimensão biológica com a comportamental.



Psicológica – esta dimensão é descrita por Gaspar (2011) como sendo os aspectos que revelam o sentir, o pensar, o comportamento, a atribuição de sentidos e das emoções. Para o aspecto psicológico, Gioia-Martins e Rocha Júnior (2011) atribuem como a atuação do homem na sua maneira de pensar, na sua capacidade de cognição e na sua percepção do mundo à sua volta.

Social – nesta esfera o homem absorve os ensinamentos e valores culturais no qual está inserido. Para Barreto (2012), a troca de experiências entre os pares, os papéis construídos pela sociedade e as leis que regem as condutas individuais e coletivas são fatores que determinam a construção da identidade humana.

Espiritual – esta dimensão é um fator importante na configuração da personalidade. Segundo Fabry (1984), o fator espiritual introduz no indivíduo atributos da dimensão no ética, como a criatividade, a fé, a imaginação, a busca pelo sentido da vida, a possibilidade de transcender a si mesmo. Espiritualidade, segundo Belo (2008), enquanto caráter universal, comprova que nunca existiu um ser humano, em qualquer cultura ou região global, que seja desprovido de espiritualidade. O autor acrescenta que “o caráter universal da espiritualidade não nega o seu caráter singular. A espiritualidade manifesta-se das mais diferentes e criativas formas, segundo a autenticidade de cada ser humano” (BELO, 2008, p. 30).



Noética – a dimensão noética é o que difere o homem dos demais animais, pois se trata da vivência da liberdade e da responsabilidade. Assim, a essência da existência humana reside na dimensão noética, também chamada de dimensão espiritual (HOLANDA; MOREIRA, 2010).

Ambiental – este aspecto serve para designar a inter-relação do homem com o ambiente físico. Segundo Moser (1998), o indivíduo avalia e percebe o ambiente e, ao mesmo tempo, é influenciado por este, numa relação dinâmica. Isso porque o mesmo ambiente também modifica e influencia as condutas humanas.

A apresentação dos cinco constructos de forma separada serve apenas para explicações didáticas, pois as dimensões são interdependentes e funcionam a partir de uma complexa interação entre eles.

3.1. Saúde e doença

A definição de saúde para a OMS é: “[...] um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1948).



Calvetti, Muller e Nunes (2007) afirmam que, desde o início dos anos 1980, acontecem debates acerca da inclusão da espiritualidade na definição saúde.

Como doença, Chiattonne (2011) define como resultado da desarmonização do ser. A autora destaca, nesse sentido, que:

[...] estar doente implica em desequilíbrios que podem ser compreendidos, em uma visão holística, como um abalo estrutural na condição de ser, chocando-se ao processo dinâmico de existir, rompendo as relações normais do indivíduo tanto consigo quanto com o mundo que o rodeia. (CHIATTONE, 2011, p. 226).

De outra forma, Silva (2006) traz outra concepção para saúde/doença. Para o autor, saúde e doença possuem representações distintas entre os indivíduos. Assim, o autor destaca que existem pacientes com patologias crônicas que se consideram sadios e, ao mesmo tempo, outros pacientes que não apresentam patologia que atravessam algum problema de ordem pessoal, com grande importância que destrói o seu bem-estar físico. Fica comprovado, dessa forma, o paradigma ampliado que considera a totalidade do ser humano – a simbologia cultural, social e individual ligada à doença do indivíduo.

3.2. Espiritualidade

Calvetti, Muller e Nunes (2007) afirmam que o campo da psicologia dedicado à saúde tem considerado a espiritualidade e a religiosidade como fatores que auxiliam no enfrentamento da doença. Para os autores, tanto espiritualidade quanto religiosidade contribuem também para a melhoria da qualidade de vida e a prevenção de doenças, por envolver dimensões sadias do desenvolvimento humano.

Camon (2002) revela que o profissional da saúde muitas vezes se depara com a espiritualidade de maneira indissolúvel, mas, também, nem sempre admitida. Para o autor, “[...] negar tais premissas é negar que podemos atingir níveis de consciência e de evolução transcendental independente da maneira como conceituamos tais fenômenos” (CAMON, 2002).

Silva (2006) afirma que, mesmo os estudos na área de psicologia sobre espiritualidade abrindo espaço cada vez mais, ainda existem controvérsias sobre a importância do tema e a possibilidade da inserção da espiritualidade como dimensão a ser estudada.

As expressões espiritualidade e religiosidade são comumente utilizadas como sinônimas, mas têm significados e aplicações distintos. Panzini *et al.* (2007) definem espiritualidade como o significado atribuído à vida, a partir de crenças e valores pessoais que interferem diretamente no comportamento e no estilo de vida do indivíduo. Ou seja, espiritualidade



é uma busca pessoal por respostas às questões existenciais, podendo ter ou não relação com algum ser sagrado. Os mesmos autores definem que religiosidade se caracteriza pela forte presença do poder sobrenatural de um criador do universo. Os religiosos apresentam um conjunto de crenças sobre a existência e seguem práticas e rituais próprios da sua religião.

Sobre espiritualidade, Camon (2002) afirma que se pode vivenciá-la mesmo a partir da conceituação do ateísmo. Segundo o autor, a busca pela espiritualidade ou transcendência não significa necessariamente uma busca de Deus, demonstrando, assim, que tem caráter particular e subjetivo, isto é, sem precisar seguir verdades absolutas impostas pelas religiões.

Koenig (2005) argumenta sobre a necessidade de incluir a espiritualidade nos tratamentos de saúde e de considerar as necessidades espirituais dos pacientes para êxito no tratamento. O autor relaciona os seguintes motivos:

- » muitos pacientes são religiosos e suas crenças ajudam a lidar com vários aspectos na vida;
- » as crenças religiosas influenciam as decisões médicas, principalmente nas situações mais críticas;
- » as crenças e atividades religiosas estão associadas à melhor saúde e qualidade de vida;
- » muitos pacientes gostariam de falar sobre sua espiritualidade.

O autor acrescenta que alguns pacientes acreditam na existência de um Deus que está à frente da situação ou que tenha permitido o sofrimento pelo qual estão passando, como forma de aprendizado e fortalecimento. Isso auxilia o paciente na redução da ansiedade, no aumento da esperança ou no senso de controle. Assim, segundo o autor, as práticas religiosas auxiliam o paciente na regulação das emoções durante o seu tratamento.

As evidências de resultados positivos oferecidos pela espiritualidade no tratamento de doenças são destacadas por Panzini *et al.* (2007):

[...] Os profissionais da saúde possuem indicações científicas do benefício da exploração da espiritualidade na programação terapêutica de qualquer doença. A parede entre medicina e espiritualidade está ruindo: médicos e demais profissionais de saúde têm descoberto a importância da prece, da espiritualidade e da participação religiosa na melhora da saúde física e mental, bem como para responder a situações estressantes. (PANZINI *et al.*, 2007, p. 106).

Está comprovado, em diversas pesquisas, que apoio às crenças espirituais ajuda o paciente a lidar melhor com as situações estressantes que a doença promove. É uma importante intervenção que, em muitos casos, oferece consequências seguras e duradouras. Panzini *et al.* (2007) afirmam que o foco na doença vem cedendo espaço aos estudos de terapias alternativas e características mais adaptativas, como a resiliência, a criatividade, a esperança e, também, a espiritualidade. Mueller *et al.* (2001) afirmam que a maioria dos estudos que associam espiritualidade e religiosidade no tratamento de doenças encontrou que o envolvimento espiritual e religioso nos pacientes proporciona melhores índices de saúde, qualidade de vida, longevidade.

No entanto, Panzini *et al.* (2007) alertam que a religião e a espiritualidade podem ser fonte tanto de alívio quanto de desconforto ou de bem-estar e podem, também, promover estresse a depender da forma como o indivíduo se relaciona com essa dimensão. Ou seja, o alerta dos autores é que a espiritualidade não tem poderes somente benéficos, mas pode, também, desencadear prejuízos ao paciente no tratamento da sua doença. Isso caracteriza a necessidade de o profissional de saúde saber lidar com questões tão íntimas e complexas, respeitando sua individualidade.

Os prejuízos no âmbito da saúde podem ser a dificuldade de diálogo entre os profissionais de saúde, entre os profissionais de saúde e o paciente e entre equipe médica e familiares do paciente. Koenig (2005) destaca que os pacientes com intensa carga religiosa podem negar um tratamento acreditando que a fé em Deus irá curá-lo. Poderão, também, negar o começo de uma psicoterapia, seguindo orientação dos seus líderes religiosos que não atribuem importância ao profissional da área de psicologia, oferecendo-lhes escuta e aconselhamento religioso.

Erroneamente, muitos psicólogos preferem se isentar de questões espirituais. Mas é importante observar que a psicologia tanto no nível acadêmico quanto no de atuação também se distancia desse assunto, o que dificulta ainda mais o debate e a discussão sobre a atuação do psicólogo a partir do surgimento de aspectos espirituais no decorrer do seu trabalho.

As mais diversas histórias culturais da humanidade sempre remetem ao espiritual, ao sobrenatural, ao inexplicável. Gaarder, Hellern e Notaker (2000) afirmam que não existe tribo ou raça que não tenha desenvolvido uma crença para explicar a criação do mundo, a origem do homem e o significado do ser humano.

Erthal (2004) afirma que a física moderna fomentou uma nova discussão sobre a concepção humana acerca do universo. Segundo o autor, os estudos sobre o mundo atômico e subatômico proporcionaram novos conceitos na ciência, reaproximando a filosofia e a ciência, que se encontravam unidas no século VI a.C.



O termo “psicologia” tem origem no vocábulo grego *psyque*, segundo Netto (1974). A expressão *psyque* pode ser traduzida como alma ou espírito e entendida como concepção, entendimento. A psicologia moderna se afasta desse conceito e recorre a uma perspectiva positivista. Belo (2008) destaca o pioneirismo de Jung quando admitiu a espiritualidade como realidade na psicologia. Jung (2012) afirma sua convicção de que a religião é uma das mais antigas e universais manifestações da alma humana, no seu livro “Psicologia e religião”.

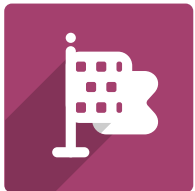
Camon (2011) exalta a necessidade de novos rumos teóricos dos conceitos utilizados até agora. O psicólogo não pode se esquecer de que é um agente de mudança. Acatar o novo paradigma holístico proposto na psicologia da saúde é responder positivamente por todos os anseios da ciência e da sociedade. O campo da saúde é amplo e profundo. Os psicólogos devem conquistar todos os espaços pertinentes ao campo da psicologia a partir de uma atuação consistente e responsável.

No âmbito do seu trabalho na área clínica, o psicólogo se depara com o desafio de saber conciliar a religiosidade e a espiritualidade dos pacientes que buscam dar sentido à sua vida. Koenig (2005) argumenta que o paciente nem sempre encontra espaço para falar de forma aberta e livre sobre suas crenças mais profundas. O autor acrescenta que o paciente, por isso, não mantém uma comunicação eficaz com os profissionais de saúde e, assim, dispara um ciclo vicioso, recebendo os cuidados de saúde de que necessitam.

Os fenômenos da religiosidade e da espiritualidade podem auxiliar nossos pacientes na busca dos seus próprios estilos de ser. O reconhecimento da religiosidade e da espiritualidade nos processos de diagnóstico e terapêuticos das enfermidades pode servir como um indicador da personalidade do paciente e contribuir de maneira significativa no seu tratamento.



Leia o artigo “Espiritualidade no processo saúde-doença-cuidado do usuário oncológico: olhar do enfermeiro”, de Hedi Crecencia Heckler de Siqueira e colaboradores, disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/110202/22099>.



PARA (NÃO) FINALIZAR

Existe, entre muitos estudiosos e profissionais da área médica, a percepção de que a espiritualidade atua como elemento facilitador no processo saúde/doença. No entanto, ao mesmo tempo, a espiritualidade não se destaca como tema a ser debatido no *setting*, tampouco é utilizada como recurso para a promoção da saúde e do bem-estar das pessoas.

A psicologia se apresenta na área da saúde para atendimento às demandas emocionais dos pacientes, além de auxiliá-los nos impactos psicológicos no processo saúde-doença. Cada vez mais, o psicólogo conquista o seu espaço como profissional indispensável na área de saúde. esse espaço traz maior responsabilidade e a formação de uma grande área da psicologia – a psicologia da saúde.

O psicólogo, ao se deparar com um paciente nas rotinas clínicas, deve ter o compromisso de aplicar meios humanizados para o seu tratamento, buscando sempre compreender o que é saudável para ele e, portanto, oferecer espaço para a sua subjetividade. Partindo da premissa de que a religiosidade e a espiritualidade são fatores presentes na constituição da subjetividade dos indivíduos, é fundamental que todos os profissionais de saúde saibam lidar com esses fenômenos de maneira adequada.

A literatura não formou consenso na discussão sobre se a relação entre religião/espiritualidade e saúde é sempre positiva. Segundo Farris e Rosa (2011), essa relação pode ser inconsistente e ambígua, podendo a fé, ou a religião, promover ou desencorajar bem-estar psicológico dos indivíduos. Segundo Larson *et al.* (1996), o componente religioso é um fenômeno multidimensional, clinicamente pertinente e tem o potencial para beneficiar, frequentemente, ou prejudicar, ocasionalmente, a saúde mental.

Cabe aos profissionais de saúde prestar um atendimento humanizado, que é muito mais do tratamento da doença em si. É a compreensão das necessidades psicossociais, emocionais e espirituais apresentadas verbalmente, ou mesmo de maneira velada pelo paciente. Para que isso ocorra, é preciso que o profissional esteja integralmente imbuído de respeito, solidariedade, conhecimento teórico-científico, além de possuir habilidades para uma comunicação capaz de auxiliar o paciente na redução do sofrimento e na busca pela sua espiritualidade.



REFERÊNCIAS

- ADAMS, D. **O guia do mochileiro das galáxias**. São Paulo: Arqueiro, 2010.
- ALES BELLO, A. **Fenomenologia e ciências humanas**. Baurur: EDUSC, 2004.
- ALLPORT, G. W. **Personalidade padrões e desenvolvimento**. São Paulo: Herder; Editora da Universidade de São Paulo, 1966.
- ALMEIDA, A. A. S.; ODA, A. M. G. R.; DALGALARRONDO, P. O olhar dos psiquiatras brasileiros sobre os fenômenos de transe e possessão. **Rev. Psiquiatr. Clín.**, v. 34, n. 1, pp. 34-41, 2007.
- ALMEIDA, M. S. P. A natureza entre Oriente e Ocidente: uma leitura de Grande Sertão: Veredas e as perspectivas filosófico-culturais. **Rios Eletrônica - Revista Científica da FASETE**, ano 7, 2013.
- ALMEIDA, R. **A Igreja Universal e seus demônios**. São Paulo: Terceiro Nome, 2009.
- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **DSM-IV**: manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Trad. Dayse Batista. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 1995.
- ANANDARAJAH, G.; HIGHT, E. Spirituality and medical practice: using the HOPE questions as a practical tool for spiritual assessment. **Am. Fam. Physician.**, v. 63, n. 1, pp. 81-89, 2001.
- ANCONA-LOPEZ, M. Psicologia e religião: recursos para construção do conhecimento. **Revista Estudos de Psicologia**, Campinas, v. 19, n. 2, pp. 78-85, maio/ago. 2002.
- ANCONA-LOPEZ, M. Religião e psicologia clínica: quatro atitudes básicas. In: MASSIMI, M. E.; MAHFOUD, M. (org.). **Diante do mistério**. São Paulo: Edições Loyola, pp. 71-86, 1999.
- AQUINO, T. A. A. Atitude religiosa e crenças dos alunos de psicologia. **Revista da Unipê**, v. 9, n. 1, pp. 56-63, 2005.
- AQUINO, T. A. A. **Logoterapia e análise existencial**: uma introdução ao pensamento de Viktor Frankl. São Paulo: Paulus, 2013.
- ARANTES, M. M. **O (des)conhecimento sobre a influência das emoções na relação professor-aluno**. 2014. 189 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014.
- ARANTES, M. M.; FERREIRA, A. L. Reflexões sobre o ser humano integral e a concepção de saúde. **Rev. Enferm. Digit. Cuid. Promoção Saúde**, v. 4, n. 2, pp. 140-145, jul./dez 2019.
- BARCELLOS, J. C. **Literatura e espiritualidade**: uma leitura de Jeunes Années, de Julien Green. São Paulo: EDUSC, 2001.
- BARRETO, R. A. D. N. **Fundamentos antropológicos e sociológicos**. Aracaju: Fits, 2012.
- BARROS-OLIVEIRA, J. H. Espiritualidade e religião: tópicos de psicologia positiva. **Psicologia Educação e Cultura**, v. XI, n. 2, pp. 265-287, 2007. Disponível em: <https://www.positivapsicologia.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Espiritualidade-e-religi%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2022.
- BELO, R. A. **Espiritualidade**: dialógica e experimental – a perspectiva da psicologia fenomenológica existencial diante da espiritualidade humana. Maceió: EDUFAL, 2008.
- BERGER, P. **O dossel sagrado**: elementos para uma teoria sociológica da religião. São Paulo: Paulinas, 1985.

REFERÊNCIAS

- BERGIN, A.; PAYNE, I. R.; RICHARDS, P. S. Values in psychotherapy. In: SHAFRANSKE, E. P. **Religion and the clinical practice of psychology**. Washington, D. C.: American Psychological Association, 1996. Cap 11.
- BLANCH, A. Integrating religion and spirituality in mental health: the promise and the challenge. **Psychiatric Rehabilitation Journal**, v. 30, pp. 251-260, 2007.
- BOFF, L. **Espiritualidade**: um caminho de transformação. Rio de Janeiro: Sextante, 2006.
- BORGATTA, E. F. The structure of personality characteristics. **Behavioral Science**, v. 12, pp. 8-17, 1964.
- BOSCAGLIA, N. *et al.* The contribution of spirituality and spiritual coping to anxiety and depression in women with a recent diagnosis of gynecological cancer. **Int. J Gynecol. Cancer**, v. 15, n. 5, pp. 755-761, 2005.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria n. 2.488, de 21 de outubro de 2011**. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011.
- BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.
- BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1990.
- CAIRD, D. Religion and personality: are mystics introverted, neurotic or psychotic? **Br J Soc. Psychol.**, v. 26, pp. 345-346, 1987.
- CALVETTI, P. U.; MULLER, M. C.; NUNES, M. L. T. Psicologia da saúde e psicologia positiva: perspectivas e desafios. **Psicologia, Ciência e Profissão**, v. 27, n. 4, pp. 706-717, 2007.
- CAMON, V. A. A. O papel da espiritualidade na prática clínica. In: CAMON, V. A. A. **Novos rumos na psicologia da saúde**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.
- CAMON, V. A. A. O ressignificado da prática clínica e suas implicações na realidade social. In: CAMON, V. A. A. **Psicologia da saúde**: um novo significado para a prática clínica. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
- CASASSUS, J. **Fundamentos da educação emocional**. 1. ed. Brasília: Unesco; Liber Livro, 2009.
- CECCARELLI, P. R. Mitologia e perversão. In: PASTORI, S.; NICOLAU, R. (org.). **Encontro transcultural**: subjetividade e psicopatologia no mundo globalizado. pp. 61-88. São Paulo: Escuta, 2012.
- CHARBAJE, R. R. *et al.* Budismo: movimento religioso de respeito à natureza. **Sinapse Múltipla**, ano 2, n. 1, pp. 22-26, jun. 2013.
- CHIATTONE, H. B. C. A significação da psicologia no contexto hospitalar. In: CAMON, V. A. A. (org.). **Psicologia da saúde**: um novo significado para a prática clínica. 2. ed. pp. 145-241, Cap. 5. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
- CLONINGER, C. R.; SVRAKIC, N. M.; SVRAKIC, D. M. Role of personality self-organization in development of mental order and disorder. **Dev. Psychopathol.**, v. 9, pp. 881-906, 1997.



- CLONINGER, C. R.; SVRAKIC, D. M.; PRZYBECK, T. R. A psychobiological model of temperament and character. **Arch. Gen. Psychiatry**, v. 50, 1993.
- CORDEIRO, E. P. B. **Formação humana para jovens e adultos**: elaboração, implementação e teste de um componente curricular em cursos tecnológicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Tese (Doutorado em História e Filosofia da Educação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012.
- COSTA, P. T.; MCCRAE, R. R. Primary Traits of Eysenck's P-E-N System: Three- and Five-Factor Solutions. **Personality Processes and Individual Differences**, v. 69, n. 2, pp. 308-317, 1995.
- CURLIN, F. A. *et al.* Religion, conscience, and controversial clinical practices. **The New England Journal of Medicine**, v. 356, n. 6, pp. 593-600, 2007.
- DURKHEIM, E. **As formas elementares da vida religiosa**. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
- ELIADE, M. **O sagrado e o profano**: a essência das religiões. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
- ERTHAL, T. C. S. A luz da sabedoria na psicoterapia. In: CAMON, V. A. A. (org.). **Espiritualidade e prática clínica**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.
- EVARISTO, P. **A Presença de Deus em Gênesis e Êxodo**. Dissertação de Mestrado não publicado. São Paulo: Faculdade Teologia Batista em São Paulo, 1997.
- EYSENCK, H. J. **The structure of human personality**. London: Methuen, 1953.
- EYSENCK, H. J. **Estudio científico de la personalidad**. Buenos Aires: Editorial Paidós, 1959.
- FABRY, J. B. **A busca do significado**. Tradução Equipe da ECE. São Paulo: ECE, 1984.
- FARRIS, R.; ROSA, R. S. Religião salugênica e religião patogênica: uma aproximação à luz da psicologia. **Revista Pistis & Praxis, Teologia e Pastoral**, v. 3, n. 2, pp. 361-382, 2011.
- FERRER, J. N. **Participation and the mystery**: transpersonal essays in psychology, education, and religion. New York: State University of New York Press, 2017.
- FERRER, J. N. **Revisioning transpersonal theory**: a participatory vision of human spirituality. New York: State University of New York Press, 2002.
- FISKE, D. W. Consistency of the factorial structures of personality ratings from different sources. **Journal of Abnormal and Social Psychology**, v. 44, pp. 329-344, 1949.
- FLECK, M. P. A. *et al.* Desenvolvimento do WHOQOL, módulo espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais. **Revista de Saúde Pública**, v. 37, n. 4, pp. 446-455, 2003.
- FLOR DE LÓTUS: conheça as curiosidades da planta oriental. Viva Decora Blog, 26 set. 2018. Disponível em: <https://www.vivadecora.com.br/revista/flor-de-lotus/>. Acesso em: 12 nov. 2022.
- FLORES-MENDOZA, C.; COLOM, R. **Introdução à psicologia das diferenças individuais**. Porto Alegre: Artmed, 2006.
- FONTOURA, R. T.; MAYER, C. N. Uma breve reflexão sobre a integralidade. **Rev. Bras. Enferm.**, v. 59, n. 4, pp. 532-537, jul./ago. 2006.
- FRANCA, L. **A psicologia da fé**. 7. ed. Rio de Janeiro: Livraria Agir Editora, 2000.

REFERÊNCIAS

- FRANKL, V. E. **Em busca de sentido**: um psicólogo no campo de concentração. São Leopoldo: Sinodal; Petrópolis: Vozes, 1994.
- FRANKL, V. E. **A psicoterapia na prática**. São Paulo: Papirus, 1991.
- FREITAS, M. H. Psicologia religiosa, psicologia da religião/espiritualidade, ou psicologia e religião/espiritualidade? **Revista Pistis & Praxis – Teologia e Pastoral**, v. 9, n. 1, pp. 89-107, 2017.
- FREUD, S. (1910) Atos obsessivos e práticas religiosas. Rio de Janeiro: Imago, 1976.
- GAARDER, J.; HELLERN, V.; NOTAKER, H. **O livro das religiões**. 10. ed. São Paulo: Cia. das Letras, 2000.
- GARCÍA, L. F. Teorias psicométricas da personalidade. *In*: Flores-Mendoza, C.; Colom, R. (org.). **Introdução à psicologia das diferenças individuais**. pp. 219-241. Porto Alegre: Artmed, 2006.
- GASPAR, K. C. Psicologia hospitalar e a oncologia. *In*: CAMON, V. A. A. (org.). **Psicologia da saúde**: um novo significado para a prática clínica. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
- GIOIA-MARTINS, D.; ROCHA JÚNIOR, A. Psicologia da saúde e o novo paradigma: novo paradigma? **Psicologia: Teoria e Prática**, v. 3, pp. 35-42, 2001.
- GIUSSANI, L. **O senso religioso**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.
- GOLDBERG, D. T. Poluting the body politic: racist discourse and urban location. *In*: CROSS, M.; KEITH, E. M. **Racism, the City and the State**. pp. 45-60. London; New York: Routledge, 1993.
- GOLDBERG, L. R. An alternative “description of personality”: the Big-Five Factor Structure. **J Pers. Soc. Psychol.**, v. 59, n. 6, pp. 1216-1229, 1990.
- GUIMARÃES, H. P.; AVEZUM, Á. O impacto da espiritualidade na saúde física. **Rev. Psiq. Clín.**, v. 34, supl 1, pp. 88-94, 2007.
- HALL, C. S.; LINDZEY, G.; CAMPBELL, J. B. **Teorias da personalidade**. Porto Alegre: Artmed, 2000.
- HEFTI, R. Integrando espiritualidade no cuidado com a saúde mental, psiquiatria e psicoterapia. **Interação em Psicologia**, Curitiba, v. 23, n. 2, ago. 2019.
- HELLERN, V.; NOTAKER, H.; GAARDER, J. **O livro das religiões**. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
- HOLANDA, A.; MOREIRA, N. Logoterapia e o sentido do sofrimento: convergências nas dimensões espiritual e religiosa. **Psico-USF**, v. 15, n. 3, pp. 345- 356, set./dez. 2010.
- HOOD, R. W. Conceptual criticism of regressive explanations of mysticism. **Rev. Religious Res.**, v. 17, pp. 179-188, 1976.
- HUTZ, C. S. *et al.* O desenvolvimento de marcadores para a avaliação da personalidade no modelo dos cinco grandes fatores. **Psicologia: Reflexão e Crítica**, v. 11, n. 2, pp. 395-411, 1998.
- JAMES, W. **The varieties of religious experience**. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1902.
- JUNG, C. G. **Psicologia e religião**. Tradução do Pe. Dom Mateus Ramalho Rocha; revisão técnica de Dora Ferreira da Silva. 10. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.
- JUNG, C. G. **Psicologia e religião**. Petrópolis, RJ: Vozes, Petrópolis, 1978. (Obras completas de C. G. Jung, v. 11/1).



- KOENIG, H. G. **Medicina, religião e saúde**: o encontro da ciência e da espiritualidade. Tradução de Iuri Abreu. Porto Alegre, RS: L&PM, 2012.
- KOENIG, H. G. **A espiritualidade no cuidado com o paciente**: por que, quando, como e o que. São Paulo: FE, 2005.
- KOENIG, H. G. Religion and medicine II: religion, mental health, and related behaviors. **Int. J Psychiatry Med.**, v. 31, n. 1, pp. 97-109, 2001.
- KOENIG, H. G.; GEORGE, L. K.; PETERSON, B. L. Religiosity and remission of depression in medically ill older patients. **Am. J Psychiatry**, v. 155, n. 4, pp. 536-542, 1998.
- KOENIG, H. G.; MCCULLOUGH, M. E.; LARSON, D. B. **Handbook of religion and health**: a century of research reviewed. New York: Oxford University Press, 2001.
- LANCETTI, A.; AMARANTE, P. Saúde mental e saúde coletiva. In: CAMPOS, G. *et al.* (org.). **Tratado de saúde coletiva**. pp. 615-634. São Paulo; Rio de Janeiro: Hucitec; Fiocruz, 2006.
- LARSON, R. W.; RICHARDS, M.; MONETA, G.; HOLMBECK, G.; DUCKETT, E. Changes in adolescents' daily interactions with their families from ages 10 to 18: Disengagement and transformation. **Developmental Psychology**, 32, pp. 744-754. 1996.
- LEVIN, J. S.; MARKIDES, K. S.; RAY, L. A. Religious attendance and psychological well-being in Mexican Americans: a panel analysis of three-generations data. **Gerontologist**, v. 36, n. 4, pp. 454-463, 1996.
- LIMA, A. F. **Contribuições da teoria de Ken Wilber para pensar a integralidade na educação**. 2014. 192 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014.
- LUCCHETTI, G. *et al.* Espiritualidade na prática clínica: o que o clínico deve saber? **Rev. Bras. Clin. Med.**, v. 8, n. 2, pp. 154-158, 2010.
- LUCZINSKI, G. F. **O psicólogo clínico e a religiosidade do cliente**: impactos na relação terapêutica. 2005. 190 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005.
- MACHON, H. **O cristianismo em C. G. Jung**: fundamentos filosóficos, premissas psicológicas e consequências para a prática terapêutica. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 2016.
- MARIE, J. N. **Introdução à suma teológica**. São Paulo: Loyola, 2004.
- MARQUES, T. G. **O desenvolvimento dos objetos transcendentais e da religião fundamentado nas obras de Freud e de Winnicott**. 2019. 161 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, 2019.
- MASLOW, A. **El hombre autorrealizado**. Barcelona: Kairós, 1983.
- MATTHEIWS, D. A. **The faith factor**: proof of the healing power of prayer. Washington: Penguin Books, 1998.
- MATTOS, R. A.; PINHEIRO, R. (org.). **Cuidado**: as fronteiras da integralidade. Rio de Janeiro, RJ: Hucitec; Abrasco, 2004.
- MCCRAE, R. R. O que é personalidade? In: FLORES-MENDOZA, C.; COLOM, R. (org.). **Introdução à psicologia das diferenças individuais**. pp. 203-218. Porto Alegre: Artmed, 2006.

REFERÊNCIAS

- MCDONALD, D. A. Spirituality: description, measurement and relation to the Five Factor Model of Personality. **J Personality**, v. 68, n. 1, 2000.
- MENEZES, P. Origem do universo. **Toda matéria**, 2022. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/origem-do-universo/>. Acesso em: 8 nov. 2022.
- MINAYO, M. C. S.; HARTZ, Z. M. A.; BUSS, P. M. Qualidade de vida e saúde: um debate necessário. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, pp. 7-18, 2000.
- MOREIRA-ALMEIDA, A.; CARDEÑA, E. Diagnóstico diferencial entre experiências espirituais e psicóticas não patológicas e transtornos mentais: uma contribuição de estudos latino-americanos para o CID-11. **Rev. Bras. Psiquiatr.**, v. 33, supl. 1, pp. 21-28, 2011.
- MOSER, G. Psicologia ambiental. **Estud. Psicol.**, Natal, v. 3, n. 1, jan.-jun. 1998.
- MUELLER, P. S.; PLEVAK, D. J.; RUMMANS, T. A. Religious involvement, spirituality, and medicine: implications for clinical practice. **Mayo Clin. Proc.** 76(12):1189-1191, 2001.
- NASSER, M. C. C. **O uso de símbolos**: sugestões para sala de aula. São Paulo: Paulinas, 2006.
- NETTO, P. F. A. **Introdução à psicologia**. São Paulo: Livraria Nobel, 1974.
- NEWBERG, A.; LEE, B. The neuroscientific study of religious and spiritual phenomena: or why God doesn't use biostatistics. **Zygon**, v. 40, pp. 469-489, 2005.
- NUNES, M. A. S. M. **Recommender systems based on personality traits**. 2008. 143 f. Thesis (Doctorate on Computer Science) – Université Montpellier II – Sciences et Techniques du Languedoc, France, 2008.
- NUNES, C. H. S. S.; HUTZ, C. S.; NUNES, M. F. O. **Bateria Fatorial de Personalidade (BFP)**: manual técnico. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010.
- OLIVEIRA, J. A. **Transcendência e religião no pensamento de H. C. de Lima Vaz**. 2014. 332 f. Tese (Doutorado em Filosofia) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014.
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Constituição**. Genebra: OMS, 1948.
- OSLER, W. The faith that heals. **Br Med. J.**, v. 1, n. 2581, pp. 1470-2, 18 jun. 1910. DOI: 10.1136/bmj.1.2581.1470.
- OTTO, R. **O sagrado**: os aspectos irracionais na noção do divino e sua relação com o racional. Tradução Walter O. Schlupp. São Leopoldo: Sinodal/EST; Petrópolis: Vozes, 2007.
- OTTO, R. **O sagrado**: um estudo do elemento não/racional na ideia do divino e a sua relação com o racional. São Bernardo do Campo: Imprensa Metodista, 1985.
- PANZINI, R. G. *et al.* Qualidade de vida e espiritualidade. **Rev. Psiq. Clín.**, v. 34, supl. 1, pp. 105-115, 2007.
- PAIVA, G. J. Ciência, religião, psicologia: conhecimento e comportamento. **Psicol. Reflex. Crit.**, Porto Alegre, v. 15, n. 3, p. 561-567, 2002.
- PETERLEVITZ, L. R. **O Deus Criador**: doutrinas bíblicas. Sumaré, SP: IBNC, 2007. Disponível em: http://www.novocoracao.com.br/ebd/7_O_Deus_criador_ibnc.pdf. Acesso em: 17 nov. 2022.
- PERVIN, L. A.; JOHN, O. P. **Personalidade**: teoria e pesquisa. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.



- PIEDMONT, R. L. Does spirituality represent the sixth factor of personality? Spiritual transcendence and the Five-Factor Model. **J Personality**, v. 67, n. 6, 1999.
- PINHEIRO, M. R.; MATTOS, R. **Construção da integralidade**: cotidiano, saberes, práticas em saúde. 3. ed. Rio de Janeiro: Abrasco, 2004.
- PINTO, E. B. Espiritualidade e religiosidade: articulações. **Rever - Revista de Estudos da Religião**, v. 9, pp. 68-83, 2009.
- PRINZIE, P. *et al.* The relations between parents' big five personality factors and parenting: a meta-analytic review. **Journal of Personality and Social Psychology**, v. 97, n. 2, pp. 351-362, 2009.
- PRADO, A. **Poesia reunida**. Rio de Janeiro; São Paulo: Record, 2015.
- PRADO, A. Arte como experiência religiosa. *In*: MARINA, M.; MAHFOUD, M. (org.). **Diante do mistério**: psicologia e senso religioso. pp. 17-31. São Paulo: Loyola, 1999.
- PUCHALSKI, C.; ROMER, A. L. Taking a spiritual history allows clinicians to understand patients more fully. **J Palliat. Med.**, v. 3, n. 1, pp. 129-37, 2000.
- RASIC, D. T. *et al.* Spirituality, religion and suicidal behavior in a nationally representative sample. **J Affect Disord.**, v. 114, n. 11, pp. 32-40, 2009.
- REBOLLO, I.; HARRIS, J. R. Genes, ambiente e personalidade. *In*: FLORES-MENDOZA, C. E.; COLOM, R. (org.). **Introdução à psicologia das diferenças individuais**. pp. 300-322. Porto Alegre: Artmed, 2006.
- ROCHA, J. R.; MONTEIRO, L. V. B. A dimensão espiritual na compreensão do fenômeno saúde-doença na psicologia da saúde. **Caderno de Graduação - Ciências Biológicas e da Saúde – UNIT**, Alagoas, v. 4, n. 2, 2017.
- RODHEN, H. **O espírito da filosofia oriental**. São Paulo: Martin Claret, 2008.
- RÖHR, F. **Educação e espiritualidade**: contribuições para uma compreensão multidimensional da realidade, do homem e da educação. Campinas: Mercado de Letras, 2013.
- RÖHR, F. Espiritualidade e educação. *In*: RÖHR F. (org.). **Diálogos em educação e espiritualidade**. pp. 13-15. Recife: Ed. Universitária, 2010.
- RYAN, M. B. The transpersonal William James. **Transpers. Psychol. Rev.**, v. 40, n. 1, pp. 20-40, 2008.
- SAAD, M.; MASIERO, D.; BATTISTELLA, L. R. Espiritualidade baseada em evidências. **Acta Fisiátrica**, v. 8, n. 3, pp. 107-112, 2001.
- SAFRA, G. A vivência do sagrado e a constituição do *self*. **Temas psicol.**, Ribeirão Preto, v. 6, n. 2, pp. 147-151, ago. 1998.
- SAFRA, G. **A poética na clínica contemporânea**. Aparecida: Ideias & Letras, 2004.
- SAFRA, G. Perspectivas do manejo clínico da experiência religiosa. *In*: ARCURI, I. G.; ANCONA-LOPEZ, M. (org.). **Temas em psicologia da religião**. p. 77-90, São Paulo: Vetor editora, 2007.
- SALDANHA, V. **A psicoterapia transpessoal**. São Paulo: Rosa dos Tempos, 1999.
- SANTOS, W. S. D. *et al.* A influência dos valores humanos no compromisso religioso. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, v. 28, pp. 285-292, 2012.

REFERÊNCIAS

- SAÚDE E ESPIRITUALIDADE: reflexões a partir da narrativa de um paciente. **Revista Medicina Integrativa**, 7 set. 2021. Disponível em: <https://revistamedicinaintegrativa.com/saude-e-espiritualidade-reflexoes-a-partir-da-narrativa-de-um-paciente/>. Acesso em: 24 out. 2022.
- SANTOS, W. S. *et al.* A influência dos valores humanos no compromisso religioso. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, v. 28, n. 3, pp. 285-292, jul./set. 2012.
- SEIXAS, G. A saúde mental no trabalho: como compreender e aprender com os acontecimentos inesperados. **Sociomotiva**, [2021?]. Disponível em: <https://www.sociomotiva.com/pt-BR/pages/04f799e9-cd58-4333-9ac1-a07d4b69777b>. Acesso em: 18 out. 2022.
- SIQUEIRA, H. *et al.* Spirituality in the health-illness-care of the oncological user process: nurse's outlook. **Revista de Enfermagem UFPE**, v. 11, n. 8, pp. 2996-3004, jul. 2017.
- SILVA, J. L. L. S. O processo saúde-doença e sua importância para a promoção da saúde. **Informe em Promoção da Saúde**, v. 2, n. 1, pp. 3-5, 2006.
- SILVA, R. S. *et al.* Replicabilidade do modelo dos cinco grandes fatores em medidas da personalidade. **Mosaico: Estudos em Psicologia**, v. 1, n. 1, pp. 37-49, 2007.
- SILVA, M. B. A. M. *et al.* Espiritualidade e saúde: estudo caso-controle. **Revista da Universidade Vale do Rio Verde**, Três Corações, v. 14, n. 2, pp. 1201-1209, 2016.
- SILVA, M. A. Sistema sensorial. **Infoescola**, [20--?]. Disponível em: <https://www.infoescola.com/biologia/sistema-sensorial/>. Acesso em: 17 out. 2022.
- SMITH, T. B.; MCCULLOUGH, M. E.; POLL, J. Religiousness and depression: evidence for a main effect and the moderating influence of stressful life events. **Psychol. Bull.**, v. 129, n. 4, pp. 614-36, 2003.
- SOUZA, R. D. O princípio da existência: uma abordagem da teologia protestante sobre Deus e o universo. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, ano 7, ed. 7, v. 4, pp. 32-44, jul. 2022.
- STRAUB, R. O. **Psicologia da saúde**. Porto Alegre: Artmed, 2005.
- TEIXEIRA, E. Reflexões sobre o paradigma holístico e holismo e saúde. **Rev. Esc. Enf. USP**, v.30, n.2, p. 286-90, ago. 1996.
- TUPES, E. C.; CHRISTAL, R. E. Recurrent personality factors based on trait ratings. **Journal of Personality**, v. 60, pp. 225-252, 1992.
- VIGOTSKI, L. S. **A formação social da mente**: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
- VOLCAN, S. M. A. *et al.* Relação entre bem-estar espiritual e transtornos psiquiátricos menores: estudo transversal. **Revista de Saúde Pública**, v. 37, n. 4, pp. 440-445, 2003.
- WILBER, K. **A visão integral**: uma introdução à revolucionária abordagem integral da vida, de Deus, do universo e de tudo mais. São Paulo: Cultrix, 2009.
- WILBER, K. **A prática de vida integral**: um guia do século XXI para saúde física, equilíbrio emocional, clareza mental e despertar espiritual. São Paulo: Cultrix, 2011.
- WULFF, D. M. **Psychology of religion**: classic & contemporary. New York: John Wiley & Sons, 1997.

